

藤田医科大学岡崎医療センター 抗菌薬適正使用支援チーム
静注抗菌薬投与量ガイドンス（2025 年 5 月 20 日作成）

ペニシリン系抗菌薬

1. [ペニシリン G](#)
2. [アンピシリン](#)
3. [アンピシリン/スルバクタム](#)
4. [ピペラシリン/タゾバクタム](#)

セフェム系抗菌薬

5. [セファゾリン](#)
6. [セフメタゾール](#)
7. [セフトリアキソン](#)
8. [セフォタキシム](#)
9. [セフォペラゾン/スルバクタム](#)
10. [セフトジジム](#)
11. [セフェピム](#)

その他のβラクタム系抗菌薬

12. [メロペネム](#)
13. [アズトレオナム](#)

その他の抗菌薬

14. [レボフロキサシン](#)
15. [ミノサイクリン](#)
16. [ST 合剤](#)
17. [ダプトマイシン](#)
18. [リネゾリド](#)
19. [クリンダマイシン](#)
20. [アジスロマイシン](#)
21. [メトロニダゾール](#)

1. ペニシリン G（商品名：注射用ペニシリン G カリウム 100 万単位）

- ・ 正常腎機能の場合の推奨量：1 回 200～400 万単位 1 日 6 回
- ・ 日本の添付文書の最大投与量：2400～3000 万単位/日（IE・髄膜炎・梅毒）
- ・ 院内採用：1V100 万単位（485 円）※2400 万単位だと 11640 円

・ 疾患別の標準投与量

疾患	1 日あたりの投与量
肺炎球菌性肺炎	ペニシリン G に感性（S）：1200 万単位 ペニシリン G に中等度耐性（I）：1800 万単位
肺炎球菌性髄膜炎	2400 万単位
神経梅毒	2400 万単位
溶連菌による蜂窩織炎	1200～1800 万単位
壊死性軟部組織感染症	2400 万単位
感染性心内膜炎	1800～2400 万単位（詳細な投与量は AST/ICT に相談）

・ 投与量調整

CrCl	投与量、投与方法
50～	100%、6 回に分けて投与、または、持続投与
30～50	50～75%、4 回に分けて投与、または、持続投与
10～30	50%、4 回に分けて投与、または、持続投与
～10	20～25%、2～4 回に分けて投与、または、持続投与
血液透析	25～50%、2～4 回に分けて投与、または、持続投与 ※透析日は透析後に投与できるように時間調整する
腹膜透析	20～25%、2～4 回に分けて投与、または、持続投与
持続血液透析	50～75%、4 回に分けて投与、または、持続投与

・ 使用時の注意点

- － 1V（100 万単位）にカリウム 1.53mEq が含まれているため、溶液のカリウム濃度に注意する
- － 持続投与は、初回 200～400 万単位負荷投与（Loading）してから、続けて持続投与する
- － 持続投与は、1 日量を 2～3 分割して投与する（生食またはブドウ糖液は 1 回 250～500ml）

参考

- ・ UpToDate 2025
- ・ ペニシリン G カリウム®の添付文書
- ・ サンフォード感染症治療ガイド Update 版
- ・ CLSI. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. 34th ed. CLSI supplement M100. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2024.
- ・ カリフォルニア大学サンフランシスコ校の抗菌薬投与ガイドライン
(<https://idmp.ucsf.edu/antimicrobial-dosing-guidelines>)

2. アンピシリン（商品名：ピクシリン注射用 1g）

- ・正常腎機能の場合の推奨量：1回 2g 1日 4～6回
- ・日本の添付文書の最大投与量：通常量 4g/日より大量に使用（敗血症・IE・髄膜炎）
- ・院内採用：1V1g（481 円） ※8g だと 3848 円（12g だと 5772 円）

・標準投与量

CrCl	投与量・投与方法
50～	1回 2g 1日 4回
30～50	1回 2g 1日 3回
15～30	1回 2g 1日 2回
～15	1回 2g 1日 1回
血液透析	1回 2g 1日 1回 ※透析日は透析後投与
腹膜透析	1回 2g 1日 1回、または、1回 1g 1日 2回
持続血液透析	1回 2g 1日 3回

・高用量（敗血症、感染性心内膜炎、骨髓炎、髄膜炎、Listeria 感染症）

CrCl	投与量・投与方法
50～	1回 2g 1日 6回
30～50	1回 2g 1日 4回
15～30	1回 2g 1日 3回
～15	1回 2g 1日 2回
血液透析	1回 2g 1日 2回 ※透析日は透析後に投与できるように時間調整する
腹膜透析	1回 2g 1日 2回
持続血液透析	1回 2g 1日 4回

参考

- ・UpToDate 2025
- ・ピクシリン®の添付文書
- ・サンフォード感染症治療ガイド Update 版
- ・CLSI. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. 34th ed. CLSI supplement M100. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2024.
- ・カリフォルニア大学サンフランシスコ校の抗菌薬投与ガイドライン
(<https://idmp.ucsf.edu/antimicrobial-dosing-guidelines>)

3. アンピシリン/スルバクタム（商品名：スルバシリン静注用 1.5g）

- ・正常腎機能の場合の推奨量：1回 3g 1日 4回
- ・日本の添付文書の最大投与量：1日 12g まで（重症・難治性感染症）
- ・院内採用：1V1.5g（597 円） ※12g だと 4776 円

・投与量

CrCl	投与量・投与方法
30～	1回 3g 1日 4回
15～30	1回 3g 1日 2回
～15	1回 3g 1日 1回
血液透析	1回 3g 1日 1回 ※透析日は透析後投与 ※重症例では1日 2回まで増量可
腹膜透析	1回 3g 1日 1回
持続血液透析	1回 3g 1日 2回 ※重症例では1日 3回まで増量可

・使用時の注意点

- *Acinetobacter baumannii* 感染症に使用する場合は多めの量で治療を行う（AST/ICT に相談）

参考

- ・UpToDate 2025
- ・スルバシリン®の添付文書
- ・サンフォード感染症治療ガイド Update 版
- ・CLSI. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. 34th ed. CLSI supplement M100. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2024.
- ・カリフォルニア大学サンフランシスコ校の抗菌薬投与ガイドライン
(<https://idmp.ucsf.edu/antimicrobial-dosing-guidelines>)

4. ピペラシリン/タゾバクタム（商品名：タゾピペ配合静注用 4.5g）

- ・正常腎機能の場合の推奨量：1回 4.5g 1日 4回
- ・日本の添付文書の最大投与量：1回 4.5g 1日 4回（敗血症・肺炎・FN など）
- ・院内採用：1V4.5g（892 円） ※18g だと 3568 円

・重症例（肺炎、敗血症、発熱性好中球減少症、緑膿菌感染症）

CrCl	投与量・投与方法
100～	1回 4.5g 1日 4回 1回 4.5g 1日 3回 1回 4時間投与（長時間投与） 1回 4.5g 1日 4回 1回 3時間投与（長時間投与）
40～100	1回 4.5g 1日 4回
20～40	1回 4.5g 1日 3回
～20	1回 4.5g 1日 2回、または、1回 2.25g 1日 4回

・軽症中等症例（尿路感染症、腹腔内感染症など）

CrCl	投与量・投与方法
100～	1回 4.5g 1日 4回 1回 4.5g 1日 3回 1回 4時間投与（長時間投与） 1回 4.5g 1日 4回 1回 3時間投与（長時間投与）
40～100	1回 4.5g 1日 3回
20～40	1回 2.25g 1日 4回
～20	1回 2.25g 1日 3回

・透析患者の場合（初回は 4.5g 投与する）

血液透析	1回 4.5g 1日 2回、または、1回 2.25g 1日 3回 ※透析日は透析後に投与できるように時間調整する
腹膜透析	1回 4.5g 1日 2回、または、1回 2.25g 1日 3回
持続血液透析	1回 4.5g 1日 3回、または、1回 2.25g 1日 4回

参考

- ・UpToDate 2025
- ・タゾピペ®の添付文書
- ・厚生労働省. 抗微生物薬適正使用の手引き 第三版 別冊/補遺.
- ・サンフォード感染症治療ガイド Update 版
- ・Clin Infect Dis. 2023;77(11):1585-1590.
- ・CLSI. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. 34th ed. CLSI supplement M100. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2024.
- ・カリフォルニア大学サンフランシスコ校の抗菌薬投与ガイドライン
(<https://idmp.ucsf.edu/antimicrobial-dosing-guidelines>)

5. セファゾリン（商品名：セファゾリン Na 注射用 1g）

- ・正常腎機能の場合の推奨量：1回 2g 1日 3回
- ・日本の添付文書の最大投与量：1日 5g まで（重症・難治性感染症）
- ・院内採用：1V1g（346 円） ※6g だと 2076 円

・投与量

CrCl	投与量・投与方法
50～	1回 2g 1日 3回
30～50	IE などの重症感染症：1回 2g 1日 3回 それ以外：1回 1g 1日 3回
10～30	IE などの重症感染症：1回 2g 1日 2回 それ以外：1回 1g 1日 2回
～10	1回 1g 1日 1回
血液透析	1回 1g 1日 1回 ※透析日は透析後投与 週 3回 2g-2g-3g 透析後投与
腹膜透析	1回 1g 1日 1回
持続血液透析	1回 2g 1日 2回、または、1回 1g 1日 3回

参考

- ・UpToDate 2025
- ・セファゾリン®の添付文書
- ・サンフォード感染症治療ガイド Update 版
- ・CLSI. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. 34th ed. CLSI supplement M100. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2024.
- ・カリフォルニア大学サンフランシスコ校の抗菌薬投与ガイドライン
(<https://idmp.ucsf.edu/antimicrobial-dosing-guidelines>)

6. セフメタゾール（商品名：セフメタゾールナトリウム静注用 1g）

- ・正常腎機能の場合の推奨量：1回 1～2g 1日 3回
- ・日本の添付文書の最大投与量：1日 4g まで（重症・難治性感染症）
- ・抗微生物薬適正使用の手引き 第3版では、1回 1g 1日 3回と記載されている
- ・院内採用：1V1g（486 円） ※4g だと 1944 円

・投与量

CrCl	投与量・投与方法
80（60）～	1回 1g 1日 4回、または、1回 2g 1日 3回 ※重症感染症の場合は、CCr 60 以上で最大投与量を使用
30～80（60）	1回 1g 1日 3回、または、1回 2g 1日 2回
10～30	1回 1g 1日 2回、または、1回 2g 1日 1回
～10	1回 1g 1日 1回、または、1回 2g 2日に 1回
血液透析	1回 2g 週 3回 透析後投与
腹膜透析	1回 2g 2日 1回
持続透析	データなし（非推奨）

・使用時の注意点

- ビタミン K 依存性の凝固因子合成を阻害する可能性があるため、長期使用時は週 1 回 PT を測定する

参考

- ・セフメタゾール®の添付文書
- ・厚生労働省. 抗微生物薬適正使用の手引き 第三版 別冊/補遺.
- ・陣内ら. セフメタゾールの臨床的有效用量と Giusti-Hayton 法による用量調節の妥当性の検討. 医療薬学. 2022;48（2）：79-86.（日本のデータ）
- ・Antibiotics (Basel). 2022;11(4):456. Published 2022 Mar 28.（日本のデータ）
- ・Pharmacotherapy. 2024;44(2):149-162.
- ・サンフォード感染症治療ガイド Update 版
- ・CEFMEC 試験のプロトコール（CC $\geq$ 10 に対して 1回 1g 1日 3回）
(https://center6.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr_view.cgi?recptno=R000055809)
- ・Drug.com (<https://www.drugs.com/dosage/cefmetazole.html>)

7. セフトリアキソン（商品名：セフトリアキソンナトリウム静注用 1g）

- ・正常腎機能の場合の推奨量：1回 1～2g 1日 1～2回
- ・日本の添付文書の最大投与量：1回 2g 1日 2回（難治性または重症感染症）
- ・院内採用：1V1g（422円） ※2gだと 844円

・標準投与量

CrCl	投与量・投与方法
腎機能調整不要	1回 1～2g 1日 1回 ※重症感染症/心内膜炎/膿瘍などの場合は1回 2g 投与する
血液透析	1回 1～2g 1日 1回 ※MIC≤1 µg/mLであれば、1回 2g 週3回 透析後投与

・髄膜炎、Enterococcus faecalis による感染性心内膜炎の場合

CrCl	投与量・投与方法
腎機能調整不要	1回 2g 1日 2回

・使用時の注意点

1. 高用量・長期使用によるセフトリアキソン脳症・偽胆石症に注意する
2. Ca含有静注製剤を同じ静注ラインで同時投与してはいけない（前後に生食フラッシュ）
3. ランソプラゾールとの併用は避ける（他のPPIまたはH2遮断薬に変更する）
4. 肝障害のある透析患者では、1回 2g 1日 1回は過剰投与になる可能性がある

参考

- ・UpToDate 2025
- ・セフトリアキソン®の添付文書
- ・サンフォード感染症治療ガイド Update版
- ・CLSI. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. 34th ed. CLSI supplement M100. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2024.
- ・カリフォルニア大学サンフランシスコ校の抗菌薬投与ガイドライン
(<https://idmp.ucsf.edu/antimicrobial-dosing-guidelines>)
- ・Clin Pharmacokinet. 2006;45(5):493–501.
- ・J Antimicrob Chemother. 2023;78(8):1963–1973.

8. セフォタキシム（商品名：セフォタックス注射用 0.5g）

- ・正常腎機能の場合の推奨量：1回 2g 1日 3～4回
- ・日本の添付文書の最大投与量：1日 4g まで（重症・難治性感染症）
- ・院内採用：1V0.5g（560円） ※6gだと 6720円

・標準投与量

CrCl	投与量・投与方法
50～	1回 2g 1日 3回
10～50	1回 2g 1日 2回
～10	1回 2g 1日 1回
血液透析	1回 2g 1日 1回 ※透析日は透析後に投与できるように時間調整する
腹膜透析	1回 2g 1日 1回
持続血液透析	1回 2g 1日 2回

・中枢神経感染症（髄膜炎・脳膿瘍）の場合

CrCl	投与量・投与方法
50～	1回 2g 1日 4回
10～50	1回 2g 1日 3回
～10	1回 2g 1日 2回
血液透析	1回 2g 1日 2回 ※透析日は透析後に投与できるように時間調整する
腹膜透析	1回 2g 1日 2回
持続血液透析	1回 2g 1日 3回

参考

- ・UpToDate 2025
- ・クラフォラン®の添付文書
- ・サンフォード感染症治療ガイド Update版
- ・Johns Hopkins ABX Guide

9. セフォペラゾン/スルバクタム（商品名：ワイスタール配合静注用 1g）

- ・ 正常腎機能の場合の推奨量：1 回 2g 1 日 2 回
- ・ 日本の添付文書の最大投与量：1 日 4g
- ・ セフォペラゾン/スルバクタム 1g に、それぞれ 0.5g ずつ含まれている
- ・ 院内採用：1V1g（313 円） ※4g だと 1252 円

・ 投与量（セフォペラゾンは肝代謝薬、スルバクタムは腎代謝薬）

CrCl	投与量・投与方法
15～	1 回 2g 1 日 2 回
～15	1 回 1g 1 日 2 回 ※重症例では 1 回 2g 1 日 2 回に増量可
血液透析	1 回 1g 1 日 2 回 ※透析日は透析後に投与できるように時間調整する ※重症例では 1 回 2g 1 日 2 回に増量可
腹膜透析	データなし（他剤推奨）
持続血液透析	1 回 2g 1 日 2 回

参考

- ・ ワイスタール®の添付文書
- ・ サンフォード感染症治療ガイド Update 版

10. セフトジジム（商品名：セフトジジム静注用 1g）

- ・正常腎機能の場合の推奨量：1回 2g 1日 3回
- ・日本の添付文書の最大投与量：1日 4g まで（重症・難治性感染症）
- ・抗微生物薬適正使用の手引き 第3版では、1回 2g 1日 3回の記載あり
- ・院内採用：1V1g（686円） ※6gだと 4116円

・投与量（緑膿菌またはそれに準じる微生物を想定した場合に使用する）

CrCl	投与量・投与方法
50～	1回 2g 1日 3回
30～50	1回 2g 1日 2回
15～30	1回 2g 1日 1回
～15	1回 1g 1日 1回
血液透析	1回 1g 1日 1回 ※透析日は透析後投与 ※1回 1～2g 週3回透析後も可能
腹膜透析	1回 1g 1日 1回
持続血液透析	1回 2g 1日 2回 ※重症例では1日 3回まで増量可

※腸内細菌目細菌による非重症感染症では、投与量を半量にしてもよい（投与間隔は同様）

参考

- ・UpToDate 2025
- ・セフトジジム®の添付文書
- ・厚生労働省. 抗微生物薬適正使用の手引き 第三版 別冊/補遺.
- ・サンフォード感染症治療ガイド Update 版
- ・CLSI. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. 34th ed. CLSI supplement M100. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2024.
- ・カリフォルニア大学サンフランシスコ校の抗菌薬投与ガイドライン
(<https://idmp.ucsf.edu/antimicrobial-dosing-guidelines>)

11. セフェピム（商品名：セフェピム塩酸塩静注用1g）

- ・正常腎機能の場合の推奨量：1回2g 1日2～3回
- ・日本の添付文書の最大投与量：1回2g 1日2回（重症・難治性感染症、FN）
- ・抗微生物薬適正使用の手引き 第3版では、1回2g 1日3回の記載あり
- ・院内採用：1V1g（522円） ※6gだと3132円（4gだと2088円）

・重症例（肺炎・発熱性好中球減少症・感染性心内膜炎・髄膜炎など）・緑膿菌感染症

CrCl	投与量・投与方法
60	1回2g 1日3回
30～60	1回2g 1日2回
10～30	1回2g 1日1回、または、1回1g 1日2回
～10	1回1g 1日1回

・軽症中等症例（尿路感染症、腹腔内感染症など）

CrCl	投与量・投与方法
60	1回2g 1日2回
30～60	1回1g 1日2回
10～30	1回1g 1日1回
～10	1回500mg 1日1回

・透析患者の場合

血液透析	1回1g 1日1回 ※透析日は透析後投与 1回2g 週3回透析後投与
腹膜透析	1回1g 1日1回
持続血液透析	1回2g 1日2回、または、1回1g 1日3回

・使用時の注意点

- －高用量使用例と腎不全患者では、セフェピム脳症に注意する

参考

- ・UpToDate 2025
- ・セフェピム®の添付文書
- ・厚生労働省. 抗微生物薬適正使用の手引き 第三版 別冊/補遺.
- ・サンフォード感染症治療ガイド Update版
- ・CLSI. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. 34th ed. CLSI supplement M100. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2024.
- ・カリフォルニア大学サンフランシスコ校の抗菌薬投与ガイドライン
(<https://idmp.ucsf.edu/antimicrobial-dosing-guidelines>)

12. メロペネム（商品名：メロペネム点滴静注用 0.5g）

- ・正常腎機能の場合の推奨量：1回 1g 1日3回（髄膜炎の場合は1回 2g）
- ・日本の添付文書の最大投与量：1日 6g まで（髄膜炎）
- ・院内採用：1V0.5g（656円） ※3gだと 3936円

・標準投与量

CrCl	投与量・投与方法
50～	1回 1g 1日3回
25～50	1回 1g 1日2回
10～25	1回 500mg 1日2回
～10	1回 500mg 1日1回
血液透析	1回 500mg 1日1回 ※透析日は透析後投与
腹膜透析	1回 500mg 1日1回
持続血液透析	1回 1g 1日3回

・中枢神経感染症（髄膜炎・脳膿瘍）の場合

CrCl	投与量・投与方法
50～	1回 2g 1日3回
25～50	1回 2g 1日2回
10～25	1回 1g 1日2回
～10	1回 1g 1日1回
血液透析	1回 1g 1日1回 ※透析日は透析後投与
腹膜透析	1回 1g 1日1回
持続血液透析	1回 2g 1日2回

参考

- ・UpToDate 2025
- ・メロペネム®の添付文書
- ・サンフォード感染症治療ガイド Update 版
- ・CLSI. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. 34th ed. CLSI supplement M100. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2024.
- ・カリフォルニア大学サンフランシスコ校の抗菌薬投与ガイドライン
(<https://idmp.ucsf.edu/antimicrobial-dosing-guidelines>)

13. アズトレオナム（商品名：アザクタム注射用 1g）

- ・正常腎機能の場合の推奨量：1回 1～2g 1日 3回
- ・日本の添付文書の最大投与量：1日 4g まで（重症・難治性感染症）
- ・抗微生物薬適正使用の手引き 第3版では、1回 2g 1日 3回の記載あり
- ・院内採用：1V1g（1047 円） ※6g だと 6282 円

・標準投与量

CrCl	投与量・投与方法
30～	1回 1g 1日 3回
10～30	1回 1g 1日 2回
～10	1回 1g 1日 1回
血液透析	1回 1g 1日 1回 ※透析日は透析後投与
腹膜透析	1回 1g 1日 1回
持続血液透析	1回 1g 1日 3回、または、1回 2g 1日 2回

・重症感染症（髄膜炎など）の場合

CrCl	投与量・投与方法
30～	1回 2g 1日 3回
10～30	1回 2g 1日 2回
～10	1回 2g 1日 1回
血液透析	1回 2g 1日 1回 ※透析日は透析後投与
腹膜透析	1回 2g 1日 1回
持続血液透析	1回 1g 1日 3回、または、1回 2g 1日 2回

参考

- ・UpToDate 2025
- ・アザクタム®の添付文書
- ・厚生労働省. 抗微生物薬適正使用の手引き 第三版 別冊/補遺.
- ・サンフォード感染症治療ガイド Update 版
- ・CLSI. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. 34th ed. CLSI supplement M100. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2024.
- ・カリフォルニア大学サンフランシスコ校の抗菌薬投与ガイドライン
(<https://idmp.ucsf.edu/antimicrobial-dosing-guidelines>)

14. レボフロキサシン（商品名：レボフロキサシン点滴静注バッグ 500mg/100ml）

- ・正常腎機能の場合の推奨量：1回 500～750mg 1日1回
- ・日本の添付文書の最大投与量：1日 500mg まで
- ・抗微生物薬適正使用の手引き 第3版では、1回 750mg 1日1回の記載あり
- ・院内採用：1V500mg（1044円）
- ・内服製剤の bioavailability は良好（99%）のため、静注薬が必須ではなければ内服薬を使用
 - －内服薬の投与量は、静注製剤と同量（500mg で約 70 円）

・標準投与量（初回投与量は、腎機能に関係なく 500mg）

CrCl	投与量・投与方法
50～	1回 500mg 1日1回
20～50	1回 250mg 1日1回
～20	1回 250mg 2日1回
血液透析	1回 250mg 2日1回 ※透析日は透析後投与
腹膜透析	1回 250mg 2日1回
持続血液透析	1回 500mg 2日1回、または、1回 250mg 1日1回

・高用量の場合（重症感染症、緑膿菌・*Stenotrophomonas maltophilia* 感染症）

CrCl	投与量・投与方法
50～	1回 750mg 1日1回
20～50	1回 750mg 2日1回
～20	1回 500mg 2日1回
血液透析	1回 500mg 2日1回、または、1回 250mg 1日1回 ※透析日は透析後投与
腹膜透析	1回 500mg 2日1回、または、1回 250mg 1日1回
持続血液透析	1回 500mg 1日1回

・使用時の注意点

- －内服薬は、多価陽イオン製剤（Al, Fe, Ca, Mg, Zn）と同時投与すると吸収が低下する
→併用を避ける、または、レボフロキサシン内服の前後 2～4 時間の内服を避ける
- －1 時間かけて点滴静注する（急速静注はしてはいけない）

参考

- ・UpToDate 2025
- ・レボフロキサシン®の添付文書
- ・厚生労働省. 抗微生物薬適正使用の手引き 第三版 別冊/補遺.
- ・サンフォード感染症治療ガイド Update 版
- ・CLSI. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. 34th ed. CLSI supplement M100. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2024.
- ・カリフォルニア大学サンフランシスコ校の抗菌薬投与ガイドライン

15. ミノサイクリン（商品名：ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 100mg）

- ・正常腎機能の場合の推奨量：1回 100mg 1日2回
- ・日本の添付文書の最大投与量：1回 100mg 1日2回
- ・院内採用：1V100mg（328円） ※200mgだと656円
- ・内服製剤の bioavailability は良好（>90%）のため、静注薬が必須ではなければ内服薬を使用
 - －内服薬の投与量は、静注製剤と同量（200mg で 57.2 円）

・投与量

CrCl	投与量・投与方法
腎機能調整不要	1回 100mg 1日2回

・使用時の注意点

- －100mg を 100ml の生理食塩水または 5%ブドウ糖注射液などに溶解する
- －1時間かけて点滴静注する（急速静注はしてはいけない）
- －内服薬は、多価陽イオン製剤（Al, Fe, Ca, Mg, Zn）と同時投与すると吸収が低下する
→併用を避ける、または、ミノサイクリン内服の前後4時間の内服を避ける

参考

- ・UpToDate 2025
- ・ミノサイクリン®の添付文書
- ・サンフォード感染症治療ガイド Update 版
- ・CLSI. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. 34th ed. CLSI supplement M100. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2024.
- ・カリフォルニア大学サンフランシスコ校の抗菌薬投与ガイドライン
(<https://idmp.ucsf.edu/antimicrobial-dosing-guidelines>)

16. ST 合剤（スルファメトキサゾール・トリメトプリム）（商品名：バクトラミン注）

- ・正常腎機能の場合の推奨量：疾患によって異なる（下記参照）
- ・日本の添付文書の最大投与量：トリメトプリムとして 20mg/kg/日
※1 アンプルまたは1 錠に、SMX 400mg、TMP 80mg が含まれている
- ・院内採用：1A400mg/80mg（690 円）※9A だと 6210 円
- ・内服製剤の bioavailability は良好（70～90%）のため、静注薬が必須ではなければ内服薬を使用
 - － 内服薬の投与量は、静注製剤と同量（9 錠で 135.9 円）

・疾患別の標準投与量

疾患	1 日あたりの投与量
尿路感染症	原則内服薬を使用する
皮膚軟部組織感染症	1 回 2 錠 1 日 2 回
腹腔内感染症	S. aureus の場合、1 回 3～4 錠 1 日 2 回への増量を検討
骨・関節感染症	1 回 3～4 錠 1 日 2 回、または、8mg/kg/日 分 2～3
PCP（HIV/非 HIV 感染者）	トリメトプリム量で 15 mg/kg/日 分 3～4
Listeria 感染症	※非 HIV 感染者の PCP は、10 mg/kg/日まで減量検討可
Nocardia 脳膿瘍	
中枢神経感染症	
S. maltophilia 感染症	トリメトプリム量で 10 mg/kg/日 分 2～3

PCP：ニューモシスチス肺炎

・投与量調整

CrCl	投与量、投与方法
30～	100%
15～30	50%に減量、2 回に分けて投与
～15	25～33%に減量、1 日 1 回投与
血液透析	25～33%に減量、1 日 1 回投与 ※透析日は透析後投与
腹膜透析	25～33%に減量、1 日 1 回投与
持続血液透析	100%

・使用時の注意点

- － 禁忌：サルファ剤アレルギー、妊娠または妊娠している可能性のある女性（投与後 1 か月避妊）
- － 高用量の使用によって、副作用が高頻度で出現するため、適宜、AST/ICT に相談する

参考

- ・ UpToDate 2025
- ・ バクトラミン®とダイフェン®の添付文書
- ・ サンフォード感染症治療ガイド Update 版.
- ・ カリフォルニア大学サンフランシスコ校の抗菌薬投与ガイドライン
(<https://idmp.ucsf.edu/antimicrobial-dosing-guidelines>)

17. ダプトマイシン（商品名：ダプトマイシン静注用 350mg）

- ・正常腎機能の場合の推奨量：1回 6～12mg/kg 1日1回
- ・日本の添付文書の最大投与量：1日 6mg/kg
- ・抗微生物薬適正使用の手引き 第3版では、1回 6～10mg/kg の記載あり
- ・院内採用：1V350mg（4761円） ※2V 使用すると 9522円

・投与量

CrCl	投与量・投与方法
30～	1回 6～10 mg/kg 1日1回 ※感染性心内膜炎、E. faecium 感染症は 8～10mg/kg/日
～30	1回 6～10 mg/kg 2日1回
血液透析	1回 6～10 mg/kg 2日1回 ※透析日は透析後投与
腹膜透析	1回 6～10 mg/kg 2日1回
持続血液透析	1回 6 mg/kg 1日1回

・使用時の注意点

- －投与量は 50mg 刻みで調整する
- －肺炎（肺サーファクタントで不活化される）・髄膜炎（移行性不良）には無効である
- －CK を週 1 回以上測定する（中止基準：CK 2000 以上、または、1000 以上かつ筋肉痛あり）

参考

- ・UpToDate 2025
- ・キュビシン®の添付文書
- ・厚生労働省. 抗微生物薬適正使用の手引き 第三版 別冊/補遺.
- ・サンフォード感染症治療ガイド Update 版
- ・CLSI. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. 34th ed. CLSI supplement M100. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2024.
- ・カリフォルニア大学サンフランシスコ校の抗菌薬投与ガイドライン
(<https://idmp.ucsf.edu/antimicrobial-dosing-guidelines>)

18. リネゾリド（商品名：リネゾリド点滴静注 600mg/300ml）

- ・正常腎機能の場合の推奨量：1回 600mg 1日2回
- ・日本の添付文書の最大投与量：1回 600mg 1日2回
- ・院内採用：1V600mg（6408円） ※1200mgだと12816円
- ・内服製剤の bioavailability は良好（100%）のため、静注薬が必須ではなければ内服薬を使用
 - －内服薬の投与量は、静注製剤と同量（1200mg で約 9000 円）

・投与量

CrCl	投与量・投与方法
腎機能調整不要	1回 600mg 1日2回
～40	臨床的に安定した場合は減量検討可 1回 300mg 1日2回、または、1回 600mg 1日1回

・使用時の注意点

- －静注製剤は 5%ブドウ糖 300ml に溶解されている
- －1回 30～120 分かけて点滴静注する
- －腎不全患者では、薬剤性血小板減少症のリスクが高い

参考

- ・UpToDate 2025
- ・リネゾリド®の添付文書
- ・サンフォード感染症治療ガイド Update 版
- ・CLSI. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. 34th ed. CLSI supplement M100. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2024.
- ・カリフォルニア大学サンフランシスコ校の抗菌薬投与ガイドライン
(<https://idmp.ucsf.edu/antimicrobial-dosing-guidelines>)

19. クリンダマイシン（商品名：ダラシン S 注射液 600mg）

- ・ 正常腎機能の場合の推奨量：1 回 600mg 1 日 3 回（静注）、1 回 450mg 1 日 3 回（内服）
- ・ 日本の添付文書の最大投与量：1 日 2400mg（静注）、1 日 900mg（内服）
- ・ 院内採用：1V600mg（582 円） ※1800mg だと 1746 円
- ・ 内服製剤の bioavailability は良好（90%）のため、静注薬が必須ではなければ内服薬を使用
 - － 内服薬の投与量は、本来静注製剤と同量だが、添付文書の記載から減量することが多い
 - － 1 錠 150mg 23.8 円のため、6 錠剤だと 143 円、9 錠だと 214 円

・ 投与量

CrCl	投与量・投与方法
腎機能調整不要	静注製剤：1 回 600mg 1 日 3 回 ※Toxic shock syndrome・壊死性筋膜炎：1 回 900mg に増量 内服製剤：咽頭炎 1 回 300mg 1 日 3 回 咽頭炎以外 1 回 450mg 1 日 3 回

・ 使用時の注意点

- － 生食またはブドウ糖 100ml に 1 回量を溶解する
- － 急速静注はしてはいけない（30 分以上かけて点滴静注する）

参考

- ・ UpToDate 2025
- ・ ダラシン®の添付文書
- ・ サンフォード感染症治療ガイド Update 版
- ・ カリフォルニア大学サンフランシスコ校の抗菌薬投与ガイドライン
(<https://idmp.ucsf.edu/antimicrobial-dosing-guidelines>)

20. アジスロマイシン（商品名：ジスロマック点滴静注用 500mg）

- ・正常腎機能の場合の推奨量：1回 500mg 1日1回
- ・日本の添付文書の最大投与量：1日 500mg（静注・内服）※子宮頸管炎/尿道炎には1g 単回投与可
- ・院内採用：1V500mg（1863円）
- ・市中肺炎の急性期治療以外では、通常内服薬が選択される
 - －内服薬の投与量は、静注製剤と同量（500mg で121～291円）

・投与量

CrCl	投与量・投与方法
腎機能調整不要	1回 500mg 1日1回 3日間 ※レジオネラ肺炎などでは、適宜投与期間を延長する ※クラミジア尿道炎/子宮頸管炎：1000mg 単回投与 ※肺非結核性抗酸菌症：1回 250mg 1日1回 長期間投与

・使用時の注意点

- －まずアジスロマイシン 500mg を注射用水 4.8mL に溶解した液（濃度 100mg/mL）を作成する
- －その後、5%ブドウ糖注射液 500mL に溶解して、薬剤濃度が 1.0mg/mL になるように希釈する
- －輸液を絞りたい場合は、5%ブドウ糖注射液を 250mL まで減らしてもよい
- －5%ブドウ糖注射液のかわりに生理食塩水を用いてもよい
- －2時間かけて点滴静注する

参考

- ・UpToDate 2025
- ・ジスロマック®の添付文書
- ・日本結核・非結核性抗酸菌症学会. 成人肺非結核性抗酸菌症化学療法に関する見解 -2023年改訂-
- ・サンフォード感染症治療ガイド Update 版
- ・カリフォルニア大学サンフランシスコ校の抗菌薬投与ガイドライン
(<https://idmp.ucsf.edu/antimicrobial-dosing-guidelines>)

21. メトロニダゾール（商品名：アネメトロ点滴静注液 500mg）

- ・正常腎機能の場合の推奨量：1回 500mg 1日 2～3回
- ・日本の添付文書の最大投与量：1日 2000mg（静注・内服）
- ・院内採用：1V500mg（1131円） ※1000mgだと2262円、1500mgだと3393円
- ・内服製剤の bioavailability は良好（100%）のため、静注薬が必須ではなければ内服薬を使用
 - －内服薬の投与量は、静注製剤と同量（1000mg で 144.8 円、1500mg だと 217.2 円）

・投与量

CrCl	投与量・投与方法
腎機能調整不要	嫌気性菌感染症・膣トリコモナス症：1回 500mg 1日 2回 中枢神経感染症・CDI・アメーバ赤痢：1回 500mg 1日 3回 破傷風：1回 500mg 1日 4回
～10	1回 500mg 1日 2回
血液透析	投与量調整不要
腹膜透析	投与量調整不要
持続血液透析	投与量調整不要

・使用時の注意点

- －1バイアルにメトロニダゾール 500mg/溶液 100ml が含まれている
- －1回 30～60分（短くても20分以上）かけて点滴静注する

参考

- ・UpToDate 2025.

腎機能低下はメトロニダゾール本体の血中半減期に影響しないが、活性代謝物やほぼ不活性な酢酸代謝物が蓄積し、神経障害・脳症・痙攣などの中枢神経系副作用のリスクが高まる。メトロニダゾールおよび代謝物は42～65%が透析で除去される。

- ・フラジール®・アネメトロ®の添付文書
- ・サンフォード感染症治療ガイド Update 版
- ・カリフォルニア大学サンフランシスコ校の抗菌薬投与ガイドライン
(<https://idmp.ucsf.edu/antimicrobial-dosing-guidelines>)
- ・Br Med J (Clin Res Ed). 1985;291(6496):648-650.
- ・Int J Antimicrob Agents. 2025;65(3):107403.